

NS 2223 1567526 | 552

VITOR MENDES SANTOS

IDADE: 51a PESO: 94 ALTURA: 177 PROFISSÃO: Padre
SINTOMAS: sonolência / cansaço / refluxo gástrico
QUEIXAS: coceira nas pontas e corpo.
MEDICAMENTOS: Atenolol 50mg / 1xd.
HAS
MÉDICO: Dr.º Alberto - Dr.º Fortes.
EXERCÍCIO FÍSICO: academia
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: - JANTAR: 5 (22h)
HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 7h
COCHILHO (X)SIM ()NÃO 1h DORME ACOMPANHADO ()SIM (X)NÃO ()EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA (X)SIM ()X NA SEMANA ()NÃO (às vezes) tem cachorro
FUMO ()SIM ()MAÇO/DIA XNÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 1x
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 40
OVERLAP: não MALLAMPATI: III IAH: 42, SPO2: 91% med.
79% min.
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:
CIRURGIAS: (N)NASAL (N)AMIGDALECTOMIA
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:
COMORBIDADE: (N)RESPIRATÓRIA (N)ENDÓCRINA (S)CARDÍACA
ORTOPÉDICA (N)NEUROLÓGICA ()OUTROS

30/11 avaliação
23

P= 6 cmH₂O Soltar fixador
07/12 m. de uso: 7h 35'
23 IAH= 0,7
Melhora da sonolência e do refluxo.
fua

04/01 P= 6 cmH₂O
24 m. de uso: 7h 31'
IAH= 0,6 efl
Bem adapt. ao uso, porém não consegue manter o sono.
fua

06/03/24 P= 6 cmH₂O
IAH= 0,8
m. de uso: 6h 51m
Bem adaptada ao uso, continua não conseguindo manter o sono
Natacha

17/04/24 P= 6 cmH₂O
IAH= 0,6 efl
m. de uso: 7h 40m
Bem adaptada
Siqueiras
Natacha

11/06/24 $P = 6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0,7 \text{ e/h}$
m de uso: 7h 28m
fuga: 9,1 l/m

Bem adaptada

Natasha

13/08/24 $P = 6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0,7 \text{ e/h}$
m de uso: 8h 45'
fuga: 8,6 l/m

Bem adaptada
troco filtro
Siqueiros

Natasha

12/11/24 $P = 6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0,8 \text{ e/h}$
m de uso: 8h 48'
fuga: 14,8 l/m

Bem adaptada
troco filtro

Natasha

11/02/25 $P = 6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0,8 \text{ e/h}$
m de uso: 8h 58'
fuga: 8,5 l/m

Troco filtro

Relata congestão nasal
Oriento lavar vias
nasais com soro fisiológico

Natasha

13/05/25 $P = 6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 0,9$
m de uso: 8h 50'
fuga: 5,9 l/m

Troco filtro

Natasha

CLÍNICA
DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

DR. ELTÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP 69.730

CRM-SP 62.858

NOME: Vitor Mendes Santos
EXAME nº: 5472-2 CPAP
SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
DATA: 30/10/2023
IDADE: 51 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h46min e concluído às 05h59min. A latência para o sono foi de 15 minutos e a latência para o estágio REM, de 70 minutos. O tempo total de sono foi de 404,5 minutos (06h44min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 81,9%. A distribuição do sono mostrou 15,6% de estágio 1, 55,6% de estágio 2, 14% de estágio 3 e 14,8% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 74,5 minutos em vigília, ocorreram 102 microdespertares (índice: 15,1/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 17,2/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 6,7/hora, sendo 1,6 apneia/hora e 5 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 6,7/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a média de 92% e a mínima de 76%.

(*) TTS ⇒ Tempo Total de Sono TTR ⇒ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa large (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 5,4 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos leves dos índices de apneia/hipopneia (6,7/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de distúrbio respiratório (6,7/hora), episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina e despertares. O ritmo cardíaco foi sinusal e as frequências cardíacas foram: mínima: 41; máxima: 55 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 15 min; normal até 30 min) – ele ingeriu um comprimido de zolpidem 10 mg às 21h45min. A latência para o sono REM estava normal (70 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 81,9%; normal: 85% ou acima), mas o índice de microdespertares (15,1/hora; normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (15,6%; normal: 8-10%) e 3 (14%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (14,8%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (55,6%; normal: 45-55%) permaneceu no limite superior da normalidade.

Aumento índice de movimentos periódicos de membros (17,2/hora; índice normal até 15/hora).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730



clínica
DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAMIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

CRM-SP 69.730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP 62.858

NOME: Vitor Mendes Santos
EXAME nº: 5472
SOLICITADO POR: Dr. Sidney Sredni
DATA: 25/08/2023
IDADE: 50 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h25min e concluído às 06h13min. A latência para o sono foi de 6 minutos e a latência para o estágio REM, de 123 minutos. O tempo total de sono foi de 404,5 minutos (06h44min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 86,3%. A distribuição do sono mostrou 15,1% de estágio 1, 55,4% de estágio 2, 11,1% de estágio 3 e 18,4% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 57,5 minutos em vigília, ocorreram 109 microdespertares (índice: 16,2/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 2,4/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 42/hora, sendo 0,3 apneia/hora e 41,7 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 54,7/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a média de 91% e a mínima de 79%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono

TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (42/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (54,7/hora); alguns episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, ritmo cardíaco sinusal e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 41; máxima: 57 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 6 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava alongada (123 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono adequada (86,3%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 16,2/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (15,1%; normal: 8-10%) e a redução do estágio REM (18,4%; normal: 20%). As porcentagens dos estágios 2 (55,4%; normal: 45-55%) e 3 (11,1%; normal: 10-12%) permaneceram nos limites da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros (2,4/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Escala de Sonolência de Epworth: 12 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

CRM 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730